

Valvulopatías Derechas

Introducción a las Valvulopatías Derechas

Las valvulopatías del lado derecho del corazón (tricúspide y pulmonar) son menos frecuentes que las del lado izquierdo en la práctica clínica habitual, pero mantienen una lógica semiológica muy similar a sus contrapartes izquierdas. La clave para diferenciarlas radica en su respuesta a la mecánica respiratoria y en los hallazgos específicos del examen físico sistémico.

Al igual que en el lado izquierdo, las valvulopatías se dividen en estenosis (dificultad para la apertura) e insuficiencias (falla en el cierre).

Semiología de los Soplos y Ruidos

El comportamiento de los soplos en el lado derecho sigue el mismo patrón temporal que en el lado izquierdo, lo que facilita su memorización:

TABLA 1.29.1: VALVULOPATÍA DERECHA VS HOMÓLOGA IZQUIERDA			
VALVULOPATÍA DERECHA	HOMÓLOGA IZQUIERDA	TIPO DE SOPLO	ALTERACIÓN DE RUIDOS
Estenosis Tricuspídea	Estenosis Mitral	Diastólico	R1 aumentado
Insuficiencia Tricuspídea	Insuficiencia Mitral	Holosistólico	R1 disminuido
Estenosis Pulmonar	Estenosis Aórtica	Mesosistólico (Eyectivo)	R2 disminuido
Insuficiencia Pulmonar	Insuficiencia Aórtica	Diastólico	R2 disminuido

Ruidos Cardiacos Específicos

- En las **alteraciones tricuspídeas**, el ruido que se modifica principalmente es el **R1** (cierre de las válvulas AV). - En las **alteraciones pulmonares**, se observa una disminución o debilitamiento del **R2** (específicamente el componente pulmonar P2).

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la intensidad del ruido depende de la movilidad y el estado de las valvas. En la estenosis tricuspídea, la válvula está abierta al máximo al final de la diástole y debe recorrer una mayor distancia para cerrarse al inicio de la sístole, lo que genera un R1 fuerte. En la insuficiencia, el mal coaptamiento de las valvas disminuye la energía del cierre, atenuando el R1.

El Signo de Rivero-Carvallo

Esta es la característica fundamental que permite distinguir un soplo derecho de uno izquierdo en el examen físico.

- **Maniobra:** Se solicita al paciente que realice una **inspiración profunda**.
- **Efecto:** Durante la inspiración, disminuye la presión intratorácica, lo que aumenta el retorno venoso hacia las cavidades derechas.
- **Resultado:** Al haber un mayor volumen de sangre (precarga) en el ventrículo y aurícula derecha, la intensidad de todos los soplos derechos **aumenta**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un soplo holosistólico aumenta con la inspiración, es una **Insuficiencia Tricuspídea**. Si disminuye o no cambia, es probable que se trate de una **Insuficiencia Mitral**. Este fenómeno se conoce como **Signo de Rivero-Carvallo**.

Manifestaciones Clínicas: Insuficiencia Cardíaca Derecha

A diferencia de las valvulopatías izquierdas que suelen debutar con síntomas de congestión pulmonar (disnea, ortopnea), las derechas se manifiestan con signos de congestión sistémica o **Insuficiencia Cardíaca** derecha:

- **Astenia y adinamia:** Por bajo gasto anterógrado.
- **Edema de extremidades inferiores:** Característicamente vespertino, con fóvea, simétrico.
- **Hepatomegalia:** Puede ser dolorosa (hígado de estasis) y, en casos de insuficiencia tricuspídea severa, puede presentar **pulsación hepática**.
- **Ingurgitación yugular:** Reflejo del aumento de presión en la aurícula derecha.

El Pulso Venoso Yugular

El estudio del pulso venoso es mandatorio ante la sospecha de patología tricuspídea, ya que refleja directamente la hemodinámica de la aurícula derecha.

1. Estenosis Tricuspídea: Onda "a" Gigante

La onda "a" del pulso venoso corresponde a la sístole auricular (contracción de la aurícula). - **Mecanismo:** Al existir una estenosis (obstrucción al flujo), la aurícula debe contraerse con mucha fuerza contra una válvula que no abre bien. Esta presión se transmite retrógradamente a las venas del cuello. - **Limitación:** Si el paciente entra en **Fibrilación Auricular**, la onda "a" desaparece, ya que no hay una contracción auricular efectiva.

2. Insuficiencia Tricuspídea: Onda "v" Gigante (u Onda "s")

La onda "v" normalmente representa el llenado auricular pasivo mientras la válvula tricúspide está cerrada durante la sístole ventricular. - **Mecanismo:** En la insuficiencia tricuspídea, durante la sístole del ventrículo, la sangre se devuelve masivamente hacia la aurícula. Esto genera una onda de presión muy prominente que coincide con el pulso arterial (onda "v" gigante o "ventricularización" del pulso venoso).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir la onda "a" con la "v". - Onda **a** = Sístole **A**uricular (presistólica). - Onda **v** = Llenado auricular/Sístole **V**entricular (sistólica).

Resumen de Hallazgos por Patología

TABLA 1.29.2: PATOLOGÍA VS SOPLO TÍPICO			
PATOLOGÍA	SOPLO TÍPICO	FOCO MÁXIMA AUSCULTACIÓN	HALLAZGO CLAVE
Estenosis Tricuspídea	Diastólico, aumenta en inspiración	Tricuspídeo (4to EIC paraesternal izq.)	Onda "a" gigante en pulso venoso
Insuficiencia Tricuspídea	Holosistólico, aumenta en inspiración	Tricuspídeo	Onda "v" gigante, pulso hepático
Estenosis Pulmonar	Mesosistólico eyectivo con clic	Pulmonar (2do EIC paraesternal izq.)	R2 disminuido o desdoblado
Insuficiencia Pulmonar	Diastólico (Soplo de Graham-Steell si hay HTP)	Pulmonar	Signos de sobrecarga derecha

NOTA CLÍNICA

El **Soplo de Graham-Steell** es un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar que ocurre secundario a una hipertensión pulmonar severa, muy común en pacientes con estenosis mitral evolucionada.

Consideraciones Finales para el EUNACOM

- Siempre que te describan un soplo que **varía con la respiración**, piensa en válvulas derechas.
- La **Insuficiencia Tricuspídea** es frecuentemente funcional, secundaria a la dilatación del ventrículo derecho por patologías del lado izquierdo o hipertensión pulmonar.
- El diagnóstico definitivo en todos estos casos se realiza mediante un **Ecocardiograma Doppler**, pero la sospecha clínica inicial se basa exclusivamente en los hallazgos semiológicos aquí descritos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 38 años usuaria de drogas endovenosas consulta por fiebre, escalofríos y disnea. A la auscultación: soplo holosistólico en borde esternal izquierdo bajo que aumenta con la inspiración (signo de Rivero-Carvalho). Hemocultivos positivos para *Staphylococcus aureus*."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Insuficiencia Tricuspídea secundaria a Endocarditis Infecciosa de válvula tricúspide, frecuente en usuarios de drogas EV. El aumento del soplo con la inspiración (Rivero-Carvalho) es patognomónico de origen tricuspídeo. Tratamiento: Antibióticos EV prolongados (Oxacilina/Vancomicina). Cirugía si vegetaciones > 20 mm o embolias sépticas pulmonares recurrentes.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La insuficiencia tricuspídea es la valvulopatía derecha más frecuente, generalmente funcional
- El signo de Rivero-Carvalho es el aumento del soplo tricuspídeo con la inspiración
- La estenosis tricuspídea es rara y casi siempre reumática, asociada a estenosis mitral
- La estenosis pulmonar es generalmente congénita
- El tratamiento de elección de la estenosis pulmonar severa es la valvuloplastia percutánea con balón
- La insuficiencia tricuspídea funcional se trata corrigiendo la causa (HTP, valvulopatía izquierda)
- El soplo de Graham Steell es la insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VALVULOPATÍAS DERECHAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años con estenosis mitral severa de origen reumático presenta ingurgitación yugular con onda V prominente, hepatomegalia pulsátil y soplo holosistólico en borde esternal izquierdo bajo que aumenta con la inspiración. ¿Cuál es el diagnóstico de la lesión valvular asociada?

- A)** Insuficiencia mitral
- B)** Insuficiencia tricuspídea
- C)** Estenosis tricuspídea
- D)** Estenosis pulmonar
- E)** Comunicación interventricular

PREGUNTA 2

Lactante de 6 meses con soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar, desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido y gradiente transvalvular pulmonar de 60 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Cirugía de reemplazo valvular pulmonar
- B)** Valvuloplastia percutánea con balón
- C)** Betabloqueadores a dosis máxima
- D)** Observación y seguimiento
- E)** TAVI pulmonar

PREGUNTA 3

¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspídea?

- A)** Endocarditis infecciosa
- B)** Enfermedad reumática
- C)** Funcional por dilatación del VD secundaria a hipertensión pulmonar
- D)** Síndrome carcinoide
- E)** Enfermedad de Ebstein

RESUMEN: VALVULOPATÍAS DERECHAS

Las valvulopatías derechas afectan a las válvulas tricúspide y pulmonar. Son menos frecuentes que las izquierdas pero clínicamente importantes. La insuficiencia tricuspídea es la más común, generalmente funcional por dilatación del ventrículo derecho secundaria a hipertensión pulmonar. La estenosis tricuspídea es rara y casi siempre de origen reumático, acompañando a la estenosis mitral. El diagnóstico se basa en la auscultación y el ecocardiograma. La insuficiencia tricuspídea produce un soplo holosistólico en foco tricuspídeo que aumenta con la inspiración (signo de Rivero-Carvallo). La estenosis pulmonar produce un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. Los signos de congestión venosa sistémica incluyen ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema periférico y ascitis. El tratamiento de la insuficiencia tricuspídea funcional se centra en tratar la causa de la hipertensión pulmonar y la valvulopatía izquierda asociada. La cirugía tricuspídea se considera cuando se realiza cirugía de válvula izquierda concomitante. La estenosis pulmonar congénita severa se trata con valvuloplastia percutánea con balón, que es el tratamiento de elección.